

FICHE DE SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE ET DU POST-PARTUM

Modèle de formulaire neutre (spécimen)

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°1/10

N° de la fiche : 2026-823-001

Région : Rabat-Salé-Kénitra

Province : Kénitra

Nom de l'établissement sanitaire : CSCA Al Wifaq

Type de l'établissement sanitaire :

- DR

☐
- CSC

☐
- CSU

☐
- CSCA

☒
- CSUA

☐

- ☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : Tazi Meryem

☐ Grossesse classée à risque :

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ H.T.A

☐ Diabète

☐ Cardiopathie

☐ Métrorragie

☐ Infection

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°1/10

Age : 31

CIN : CB609814

Niveau d'instruction : Lycée

Profession : Étudiante

Adresse : 49 Rue Al Qods, Kénitra

Téléphone : 06 00 76 13 48

Nom du Mari : Mohamed Tazi

Profession : Ouvrier

☐ Consanguinité

☒ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA	RAS	RAS
Diabète	RAS	RAS
Maladies héréditaires	Père	RAS
Malformations	RAS	RAS
Allergie(s)	RAS	RAS

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques
RAS	Aucun	Cycles réguliers

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date	12/11/2022				
Modalité d'extraction	Voie basse				
Si césarienne : indication					
Complication (type)	RAS				
Poids nouveau-né(s)	3626 g				
Compl. nouveau-né (type)	RAS				

Gestation : 3 Parité : 1 Nombre d'enfants vivants : 1

VAT : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole Le 12/05/2022

☐ Vaccinée contre l'hépatite B Le

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : Normal

DDR : 26/04/2025

Taille : 155 cm

Groupage : ☐ A ☒ B ☐ O ☐ AB ☐ Rh- ☒ Rh+

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : 31/01/2026

DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME : 07/02/2026

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous		17/08/2025			26/10/2025	29/11/2025	29/12/2025	26/01/2026	—
Venue le		20/07/2025			28/09/2025	01/11/2025	01/12/2025	29/12/2025	18/01/2026
Visites de relance		Oui			Non	Non	Non	Non	Non
Age probable		12 SA			22 SA	27 SA	31 SA	35 SA	38 SA
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)		58.8			62.7	64.3	64.8	66.2	66.8
TA		104/74			106/77	102/60	103/66	115/63	110/60
Anomalies squelette		RAS			RAS	RAS	RAS	RAS	RAS
État des conjonctives		Normales			Normales	Normales	Normales	Normales	Normales
Examen des seins		Normaux			Normaux	Normaux	Normaux	Normaux	Normaux
Œdèmes		Non			Non	Non	Non	Non	Non
Mouvements actifs		—			Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
HU (cm)		—			18	23	27	31	34
BCF		—			150	148	149	139	148
Examen au spéculum		—			—	—	—	—	—
TV : état du col		—			—	—	Fermé	Fermé	Fermé
TV : présentation		—			—	—	—	Céphalique	Céphalique
TV : bassin		—			—	—	—	—	—
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie		Neg			Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
Albuminurie		Neg			Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
Rubéole		Immune							
Toxoplasmose		Immune							
Syphilis (TPHA/VDRL)		Neg							
Ag HBs		Neg							
Sérologie VIH		Neg							
Hémoglobine		11.8 g/dL			11.4 g/dL				
Plaquettes		186k							
Bilan glycémique		0.93 g/L							
RAI (si Rh négatif)		Neg							
TRAITEMENT									
Fer		Oui			Oui				
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par		Dr Benjelloun			Sage-femme	Inf. Zahra	Dr Benjelloun	Dr Chakir	Sage-femme

DÉROULEMENT DE L'ACCOUCHEMENT

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°1/10

Patiente : Tazi Meryem

Lieu

☒ En milieu surveillé

☐ Maison d'accouchement

☒ Maternité

☐ Clinique privée

Autres :

☐ A domicile

☐ Assisté par un personnel qualifié

Autres :

Date de l'accouchement : 03/02/2026

Mode de l'accouchement :

☒ Voie basse non instrumentale

☐ Voie basse instrumentale

☐ Forceps

☐ Ventouse

☐ Avec épisiotomie

☐ Césarienne : Programmée

☐ Urgence

Préciser l'indication :

Présence de complications

☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

☐ Hémorragie

☐ Infection

☐ Autres

Si autres à préciser :

Etat du nouveau-né :

☒ Vivant

☐ Mort-né

☐ Décès < 24 heures

Sexe : F

Poids à la naissance : 3587 g

Périmètre crânien à la naissance : 34 cm

Anomalie à préciser : Aucune

Âge gestationnel : 40 SA

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

MÈRE — Tazi Meryem

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°1/10

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement ☒
Après le 8ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : 10/02/2026

Etat général :
T° 37.2 TA 110/71 Pouls 83 Poids 66 kg
Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées
☒ Présence du globe utérin
Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide
☐ claires ☒ sanglantes ☐ Jaunâtres
Etat du périnée :
☒ Normal
☐ Épisiotomie ☐ Réparée
☐ Déchirure
Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal
☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :
Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès
Etat des mollets :
☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion
Présence de complication : ☐
☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires
☐ Infection ☐ Anémie
☐ Eclampsie ☐ Autres
☐ Phlébite
Notion de prise de médicaments : ☐
CONDUITE À TENIR :
Traitement prescrit :
☒ Fer ☒ Vitamine A
Autres à préciser :
Prochain rendez-vous le 17/03/2026

PLANIFICATION FAMILIALE
☒ Désire utiliser une méthode
Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :
☐ Prescription faite
☐ Référée :
Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°1/10

Date de la consultation : 10/02/2026

Age 7 jours

Température 37.1 °C

Poids 3485 g

Taille 48 cm

Périmètre crânien 34 cm

☐ Nouveau-né prématuré

☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions

☐ Refus de téter

☐ Hématémèses

☐ Mélaenas

☐ Diarrhée

☐ Ictère

☐ Tirage sous costal

☐ Toux

☐ Rythme respiratoire anormal

☐ Fièvre

☐ Hypothermie

Autres à préciser : Néant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome

☐ Luxation congénitale de la hanche

☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère

☐ Infection

☐ Conjonctivite

☐ Traumatisme

☐ Malformation

☐ Autres

Vu par : Inf. Zahra

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : Néant

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 12/03/2026

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE — Tazi Meryem

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°1/10

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement



Date de la consultation : 18/03/2026

Après le 50ème jour de l'accouchement



Etat général :

T° 37.0

TA 107/71

Pouls 75

Poids 64 kg

Etat des conjonctives : ☒ Normales

☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies :

☒ Fade

☐ fétide

☒ claires

☐ sanglantes

☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal

☐ Épisiotomie

☒ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) :

☒ Normal

☐ Anormal

☐ Césarienne :

Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal

☐ lymphangite

☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal

☐ Rouges

☐ Chauds

☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication :



☐ Hémorragie

☐ Complications mammaires

☐ Infection

☐ Anémie

☐ Eclampsie

☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments :



CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer

☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle :

☒ pilule

☐ DIU

Autre à préciser :

☒ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°1/10

Date de la consultation : 18/03/2026

Age 43 jours Température 36.8 °C Poids 5218 g

Taille 58 cm Périmètre crânien 37 cm

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☐ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☒ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : Néant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Evaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : Inf. Zahra

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : Néant

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 17/05/2026

FICHE DE SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE ET DU POST-PARTUM

Modèle de formulaire neutre (spécimen)

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°2/10

N° de la fiche : 2026-416-002

Région : Fès-Meknès

Province : Meknès

Nom de l'établissement sanitaire : CSC Hay Salam

Type de l'établissement sanitaire :

DR ☐

CSC ☒

CSU ☐

CSCA ☐

CSUA ☐

☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : Ouazzani Khadija

☒ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☒ H.T.A

☐ Diabète

☐ Cardiopathie

☐ Métrorragie

☐ Infection

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°2/10

Age : 21

CIN : Cj292996

Niveau d'instruction : Aucun

Profession : Agricultrice

Adresse : 33 Rue Zerkouni, Meknès

Téléphone : 06 00 48 18 24

Nom du Mari : Ahmed Ouazzani

Profession : Chauffeur

☐ Consanguinité

☒ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA	RAS	RAS
Diabète	RAS	RAS
Maladies héréditaires	oncle	RAS
Malformations	RAS	RAS
Allergie(s)	RAS	RAS

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques
RAS	Aucun	Cycles réguliers

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date	21/03/2018	28/07/2021	03/09/2022		
Modalité d'extraction	Voe basse	Voe basse	Voe basse		
Si césarienne : indication					
Complication (type)	RAS	RAS	RAS		
Poids nouveau-né(s)	3626 g	3679 g	3001 g		
Compl. nouveau-né (type)	RAS	RAS	RAS		

Gestation : 4

Parité : 3

Nombre d'enfants vivants : 3

VAT : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole

☒ Vaccinée contre l'hépatite B

Le 12/05/2022

Le 03/09/2021

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : Normal

Document synthétique généré pour l'entraînement de modèles — aucune donnée réelle — ne pas utiliser comme dossier médical.

DDR : 11/08/2025

Taille : 160 cm

Groupage : ☒ A ☐ B ☐ O ☐ AB ☐ Rh-

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : 18/05/2026

DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME : 25/05/2026

☒ Rh+

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous	02/11/2025	02/12/2025		20/01/2026	25/02/2026	22/03/2026	11/04/2026	11/05/2026	
Venue le	05/10/2025	04/11/2025		23/12/2025	28/01/2026	22/02/2026	14/03/2026	13/04/2026	
Visites de relance	Non	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui	
Age probable	8 SA	12 SA		19 SA	24 SA	28 SA	31 SA	35 SA	
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)	71.0	73.3		75.2	77.8	79.1	79.1	80.6	
TA	151/97	139/89		137/92	141/88	152/95	146/96	150/88	
Anomalies squelette	RAS	RAS		RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	
État des conjonctives	Normales	Normales		Normales	Normales	Normales	Normales	Normales	
Examen des seins	Normaux	Normaux		Normaux	Normaux	Normaux	Normaux	Normaux	
Œdèmes	Non	Non		Non	Non	Non	Oui	Oui	
Mouvements actifs	-	-		-	Oui	Oui	Oui	Oui	
HU (cm)	-	-		15	20	24	27	31	
BCF	-	-		129	152	129	130	132	
Examen au spéculum	RAS	-		-	-	-	-	-	
TV : état du col	-	-		-	-	Fermé	Fermé	Fermé	
TV : présentation	-	-		-	-	-	-	Céphalique	
TV : bassin	Normal	-		-	-	-	-	-	
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie	Neg	Neg		Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	
Albuminurie	Neg	Neg		Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	
Rubéole	Immune								
Toxoplasmose	Non immune								
Syphilis (TPHA/VDRL)	Neg								
Ag HBs	Neg								
Sérologie VIH	Neg								
Hémoglobine	132 g/dL			125 g/dL					
Plaquettes	247k								
Bilan glycémique	0.8 g/L								
RAI (si Rh négatif)	Neg								
TRAITEMENT									
Fer	Oui			Oui					
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par	Sage-femme	Sage-femme		Dr Benjelloun	Inf. Zahra	Inf. Zahra	Dr Benjelloun	Dr Benjelloun	

DÉROULEMENT DE L'ACCOUCHEMENT

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°2/10

Patiente : Ouazzani Khadija

Lieu

☒ En milieu surveillé

☐ Maison d'accouchement

☐ Maternité

☒ Clinique privée

Autres :

☐ A domicile

☐ Assisté par un personnel qualifié

Autres :

Date de l'accouchement : 23/05/2026

Mode de l'accouchement :

☐ Voie basse non instrumentale

☐ Voie basse instrumentale

☐ Forceps

☐ Ventouse

☐ Avec épisiotomie

☐ Césarienne : Programmée

☒ Urgence

Préciser l'indication : Souffrance fœtale

Présence de complications

☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

☐ Hémorragie

☐ Infection

☐ Autres

Si autres à préciser :

Etat du nouveau-né :

☒ Vivant

☐ Mort-né

☐ Décès < 24 heures

Sexe : M

Poids à la naissance : 3699 g

Périmètre crânien à la naissance : 34 cm

Anomalie à préciser : Aucune

Âge gestationnel : 40 SA

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

MÈRE — Ouazzani Khadija

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°2/10

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement



Date de la consultation : 30/05/2026

Après le 8ème jour de l'accouchement



Etat général :

T° 36.9

TA 117/78

Pouls 79

Poids 78 kg

Etat des conjonctives : ☒ Normales

☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies :

☒ Fade

☐ fétide

☐ claires

☒ sanglantes

☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal

☐ Épisiotomie

☐ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) :

☒ Normal

☐ Anormal

☒ Césarienne :

Etat de la cicatrice : Propre

Etat des seins : ☒ Normal

☐ lymphangite

☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal

☐ Rouges

☐ Chauds

☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication :



☐ Hémorragie

☐ Complications mammaires

☐ Infection

☐ Anémie

☐ Eclampsie

☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments :



CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer

☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le 04/07/2026

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle :

☒ pilule

☐ DIU

Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°2/10

Date de la consultation : 30/05/2026

Age 7 jours

Température 37.0 °C

Poids 3564 g

Taille 50 cm

Périmètre crânien 34 cm

☐ Nouveau-né prématuré

☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions

☐ Refus de téter

☐ Hématémèses

☐ Mélaenas

☐ Diarrhée

☐ Ictère

☐ Tirage sous costal

☐ Toux

☐ Rythme respiratoire anormal

☐ Fièvre

☐ Hypothermie

Autres à préciser : Néant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome

☐ Luxation congénitale de la hanche

☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Evaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère

☐ Infection

☐ Conjonctivite

☐ Traumatisme

☐ Malformation

☐ Autres

Vu par : Dr Benjelloun

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : Néant

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 29/06/2026

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE — Ouazzani Khadija

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°2/10

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement



Date de la consultation : 05/07/2026

Après le 50ème jour de l'accouchement



Etat général :

T° 36.8

TA 114/70

Pouls 76

Poids 78 kg

Etat des conjonctives : ☒ Normales

☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies :

☒ Fade

☐ fétide

☒ claires

☐ sanglantes

☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal

☐ Épisiotomie

☒ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) :

☒ Normal

☐ Anormal

☒ Césarienne :

Etat de la cicatrice :

Propre, sèche

Etat des seins : ☒ Normal

☐ lymphangite

☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal

☐ Rouges

☐ Chauds

☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication :



☐ Hémorragie

☐ Complications mammaires

☐ Infection

☐ Anémie

☐ Eclampsie

☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments :



CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer

☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle :

☒ pilule

☐ DIU

Autre à préciser :

☒ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°2/10

Date de la consultation : 05/07/2026

Age 43 jours Température 36.8 °C Poids 5553 g

Taille 55 cm Périmètre crânien 38 cm

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

- | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|
| ☐ Convulsions | ☐ Refus de téter | ☐ Hématémèses | ☐ Mélaenas |
| ☐ Diarrhée | ☐ Ictère | ☐ Tirage sous costal | ☐ Toux |
| ☐ Rythme respiratoire anormal | ☐ Fièvre | ☐ Hypothermie | |

Autres à préciser : Néant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

- ☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Evaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

- ☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : Dr Benjelloun

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : Néant

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 03/09/2026

FICHE DE SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE ET DU POST-PARTUM

Modèle de formulaire neutre (spécimen)

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°3/10

N° de la fiche : 2026-711-003

Région : Marrakech-Safi

Province : Al Haouz

Nom de l'établissement sanitaire : DR Tahannaout Sud

Type de l'établissement sanitaire :

DR ☒

CSC ☐

CSU ☐

CSCA ☐

CSUA ☐

☐ Fixe

☒ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : Saïdi Meryem

☐ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ H.T.A

☐ Diabète

☐ Cardiopathie

☐ Métrorragie

☐ Infection

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°3/10

Age : 23

CIN : BK941500

Niveau d'instruction : coll ge

Profession : couturi re

Adresse : 5 Rue Al Massira, Al Haouz

Téléphone : 06 00 83 58 65

Nom du Mari : Abdellah Saïdi

Profession : Fonctionnaire

☐ Consanguinité

☒ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA	RAS	RAS
Diabète	RAS	RAS
Maladies héréditaires	RAS	RAS
Malformations	RAS	RAS
Allergie(s)	RAS	RAS

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques
Asthme léger	Aucun	cycles réguliers

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date	12/03/2023				
Modalité d'extraction	Voie basse				
Si césarienne : indication					
Complication (type)	RAS				
Poids nouveau-né(s)	3186 g				
Compl. nouveau-né (type)	RAS				

Gestation : 2Parité : 1Nombre d'enfants vivants : 1

VAT : ☒ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéoleLe 12/05/2022

☒ Vaccinée contre l'hépatite BLe 03/09/2021

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : Non fait

GROSSESSE ACTUELLE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°3/10

DDR : 07/04/2025 Taille : 152 cm Groupage : ☐ A ☐ B ☒ O ☐ AB ☐ Rh-
DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : 12/01/2026 DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME : 19/01/2026 ☒ Rh+

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous	03/07/2025			03/09/2025	04/10/2025	08/11/2025		06/01/2026	
Venue le	05/06/2025			06/08/2025	06/09/2025	11/10/2025		09/12/2025	27/12/2025
Visites de relance	Non			Non	Ouï	Non		Non	Non
Age probable	8 SA			17 SA	22 SA	27 SA		35 SA	38 SA
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)	51.6			55.6	56.5	59.2		62.1	63.2
TA	104/78			118/74	120/62	115/62		101/75	118/62
Anomalies squelette	RAS			RAS	RAS	RAS		RAS	RAS
État des conjonctives	Normales			Normales	Normales	Normales		Normales	Normales
Examen des seins	Normaux			Normaux	Normaux	Normaux		Normaux	Normaux
Œdèmes	Non			Non	Non	Non		Non	Non
Mouvements actifs					Ouï	Ouï		Ouï	Ouï
HU (cm)				13	18	23		31	34
BCF				130	153	157		129	128
Examen au spéculum	RAS								
TV : état du col								Ferm	Ferm
TV : présentation								c phalique	c phalique
TV : bassin	Normal								
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie	Neg			Neg	Neg	Neg		Neg	Neg
Albuminurie	Neg			Neg	Neg	Neg		Neg	Neg
Rubéole	Immune								
Toxoplasmose	Immune								
Syphilis (TPHA/VDRL)	Neg								
Ag HBs	Neg								
Sérologie VIH	Neg								
Hémoglobine	11.7 g/dL			11.6 g/dL					
Plaquettes	263k								
Bilan glycémique	0.88 g/L								
RAI (si Rh négatif)	Neg								
TRAITEMENT									
Fer	Ouï			Ouï					
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par	Inf. Zahra			Sage-femme	Dr Benjelloun	Sage-femme		Dr Benjelloun	Dr Benjelloun

DÉROULEMENT DE L'ACCOUCHEMENT

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°3/10

Patiente : Saïdi Meryem

Lieu

☒ En milieu surveillé

☐ Maison d'accouchement

☐ Maternité

☒ Clinique privée

Autres :

☐ A domicile

☐ Assisté par un personnel qualifié

Autres :

Date de l'accouchement : 23/01/2026

Mode de l'accouchement :

☐ Voie basse non instrumentale

☒ Voie basse instrumentale

☒ Forceps

☐ Ventouse

☒ Avec épisiotomie

☐ Césarienne : Programmée

☐ Urgence

Préciser l'indication :

Présence de complications

☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

☐ Hémorragie

☐ Infection

☐ Autres

Si autres à préciser :

Etat du nouveau-né :

☒ Vivant

☐ Mort-né

☐ Décès < 24 heures

Sexe : F

Poids à la naissance : 3624 g

Périmètre crânien à la naissance : 36 cm

Anomalie à préciser : Aucune

Âge gestationnel : 41 SA

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

MÈRE — Saidi Meryem

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°3/10

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement



Date de la consultation : 30/01/2026

Après le 8ème jour de l'accouchement



Etat général :

T° 36.9

TA 100/75

Pouls 72

Poids 58 kg

Etat des conjonctives : ☒ Normales

☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies :

☒ Fade

☐ fétide

☐ claires

☒ sanglantes

☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal

☒ Épisiotomie

☒ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) :

☒ Normal

☐ Anormal

☐ Césarienne :

Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal

☐ lymphangite

☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal

☐ Rouges

☐ Chauds

☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication :



☐ Hémorragie

☐ Complications mammaires

☐ Infection

☐ Anémie

☐ Eclampsie

☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments :



CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer

☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le 06/03/2026

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle :

☐ pilule

☒ DIU

Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : 30/01/2026

Age7 jours

Température36.8 °C

Poids3538 g

Taille51 cm

Périmètre crânien36 cm

☐ Nouveau-né prématuré

☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement :

☒ exclusivement au sein

☐ Artificiel

☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions☐ Refus de téter☐ Hématémèses☐ Mélaenas

☐ Diarrhée☐ Ictère☐ Tirage sous costal☐ Toux

☐ Rythme respiratoire anormal☐ Fièvre☐ Hypothermie

Autres à préciser : N ant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome

☐ Luxation congénitale de la hanche

☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Evaluation de l'allaitement maternel :

☒ Normal

☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour :

☒ BCG

☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère☐ Infection☐ Conjonctivite

☐ Traumatisme☐ Malformation

☐ Autres

Vu par : Sage-femme Salima

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : N ant

☐ Transfert

Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le01/03/2026

Document synthétique généré pour l'entraînement de modèles — aucune donnée réelle — ne pas utiliser comme dossier médical.

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE — Saidi Meryem

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°3/10

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement ☒
Après le 50ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : 08/03/2026

Etat général :

T° 36.5 TA 112/72 Pouls 67 Poids 56 kg

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide
☒ claires ☐ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal
☐ Épisiotomie ☒ Réparée
☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets : ☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires
☐ Infection ☐ Anémie
☐ Eclampsie ☐ Autres
☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit : ☒ Fer ☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode
Si oui, laquelle : ☐ pilule ☒ DIU Autre à préciser :

☒ Prescription faite
☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°3/10

Date de la consultation : 08/03/2026

Age 44 jours Température 36.9 °C Poids 5356 g

Taille 57 cm Périmètre crânien 39 cm

☐ Nouveau-né prématuré☐ Nouveau-né hypotropheAllaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions☐ Refus de téter☐ Hématémèses☐ Mélaenas☐ Diarrhée☐ Ictère☐ Tirage sous costal☐ Toux☐ Rythme respiratoire anormal☐ Fièvre☐ Hypothermie

Autres à préciser : N ant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome☐ Luxation congénitale de la hanche☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Evaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère☐ Infection☐ Conjonctivite☐ Traumatisme☐ Malformation☐ Autres

Vu par : Sage-femme Salima

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : N ant

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 07/05/2026

FICHE DE SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE ET DU POST-PARTUM

Modèle de formulaire neutre (spécimen)

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°4/10

N° de la fiche : 2026-995-004

Région : B ni Mellal-Kh nifra

Province : Azilal

Nom de l'établissement sanitaire : CSCA Ait Mhamed

Type de l'établissement sanitaire :

DR ☐

CSC ☐

CSU ☐

CSCA ☒

CSUA ☐

☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : Benali Nadia

☐ Grossesse classée à risque :

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ Métrorragie

☐ H.T.A

☐ Infection

☐ Diabète

☐ Pré-éclampsie

☐ Cardiopathie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°4/10

Age : 26

CIN : GC417513

Niveau d'instruction : Aucun

Profession : Commerçante

Adresse : 69 Rue Mohammed V, Azilal

Téléphone : 06 00 17 14 56

Nom du Mari : Mohamed Benali

Profession : Mécanicien

☐ Consanguinité

☒ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA	RAS	RAS
Diabète	RAS	RAS
Maladies héréditaires	RAS	RAS
Malformations	RAS	RAS
Allergie(s)	Oncle	RAS

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques
RAS	Aucun	Cycles réguliers

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement	1	2023	Maternité	34 SA
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date	25/01/2016	24/03/2019	11/02/2020	10/07/2023	
Modalité d'extraction	Voie basse	Voie basse	Voie basse	Voie basse	
Si césarienne : indication					
Complication (type)	RAS	RAS	RAS	RAS	
Poids nouveau-né(s)	2851 g	3313 g	3655 g	2949 g	
Compl. nouveau-né (type)	RAS	RAS	RAS	RAS	

Gestation : 5 Parité : 4 Nombre d'enfants vivants : 4

VAT : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole Le 12/05/2022

☒ Vaccinée contre l'hépatite B Le 03/09/2021

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : Non fait

DDR : 21/09/2025

Taille : 158 cm

Groupage : ☐ A ☐ B ☒ O ☐ AB ☐ Rh-

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : 28/06/2026

DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME : 05/07/2026

☒ Rh+

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous	07/01/2026			10/02/2026	29/03/2026	25/04/2026	24/05/2026	20/06/2026	
Venue le	10/12/2025			13/01/2026	01/03/2026	28/03/2026	26/04/2026	23/05/2026	
Visites de relance	Non			Non	Non	Non	Non	Non	
Age probable	11 SA			16 SA	23 SA	27 SA	31 SA	35 SA	
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)	70.7			72.3	74.6	76.0	78.1	79.5	
TA	101/67			107/72	112/73	104/64	114/71	101/73	
Anomalies squelette	RAS			RAS	RAS	RAS	RAS	RAS	
État des conjonctives	Normales			Normales	Normales	Normales	Normales	Normales	
Examen des seins	Normaux			Normaux	Normaux	Normaux	Normaux	Normaux	
Œdèmes	Non			Non	Non	Non	Non	Non	
Mouvements actifs					Oui	Oui	Oui	Oui	
HU (cm)				12	19	23	27	31	
BCF				157	136	155	155	144	
Examen au spéculum	RAS								
TV : état du col							Ferm	Ferm	
TV : présentation								Céphalique	
TV : bassin	Normal								
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie	Neg			Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	
Albuminurie	Neg			Neg	Neg	Neg	Neg	Neg	
Rubéole	Immune								
Toxoplasmose	Non immune								
Syphilis (TPHA/VDRL)	Neg								
Ag HBs	Neg								
Sérologie VIH	Neg								
Hémoglobine	12.1 g/dL			12.3 g/dL					
Plaquettes	262k								
Bilan glycémique	0.9 g/L								
RAI (si Rh négatif)	Neg								
TRAITEMENT									
Fer	Oui			Oui					
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par	Sage-femme			Dr Benjeloun	Dr Chakir	Dr Chakir	Dr Chakir	Dr Benjeloun	

DÉROULEMENT DE L'ACCOUCHEMENT

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°4/10

Patiente : Benali Nadia

Lieu

☒ En milieu surveillé

☐ Maison d'accouchement

☐ Maternité

☒ Clinique privée

Autres :

☐ A domicile

☐ Assisté par un personnel qualifié

Autres :

Date de l'accouchement : 28/06/2026

Mode de l'accouchement :

☐ Voie basse non instrumentale

☐ Voie basse instrumentale

☐ Forceps

☐ Ventouse

☐ Avec épisiotomie

☒ Césarienne : Programmée

☐ Urgence

Préciser l'indication : Ut rus cicatriciel

Présence de complications



☒ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

☒ Hémorragie

☐ Infection

☐ Autres

Si autres à préciser :

Etat du nouveau-né :

☒ Vivant

☐ Mort-né

☐ Décès < 24 heures

Sexe : M

Poids à la naissance : 2967 g

Périmètre crânien à la naissance : 36 cm

Anomalie à préciser : Aucune

Âge gestationnel : 40 SA

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

MÈRE — Benali Nadia

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°4/10

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement



Date de la consultation : 05/07/2026

Après le 8ème jour de l'accouchement



Etat général :

T° 37.1

TA 116/76

Pouls 68

Poids 76 kg

Etat des conjonctives : Normales

☐ Décolorées

Présence du globe utérin

Etat des lochies :

Fade

☐ fétide

☐ claires

sanglantes

☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

Normal

☐ Épisiotomie

☐ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) :

Normal

☐ Anormal

Césarienne :

Etat de la cicatrice :

Propre

Etat des seins : Normal

☐ lymphangite

☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

Normal

☐ Rouges

☐ Chauds

☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication :

Hémorragie

☐ Complications mammaires

☐ Infection

☐ Anémie

☐ Eclampsie

☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments :



CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

Fer

Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le 09/08/2026

PLANIFICATION FAMILIALE

Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle :

pilule

☐ DIU

Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°4/10

Date de la consultation : 05/07/2026

Age 7 jours

Température 37.2 C

Poids 2927 g

Taille 49 cm

Périmètre crânien 36 cm

☐ Nouveau-né prématuré

☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions

☐ Refus de téter

☐ Hématémèses

☐ Mélaenas

☐ Diarrhée

☐ Ictère

☐ Tirage sous costal

☐ Toux

☐ Rythme respiratoire anormal

☐ Fièvre

☐ Hypothermie

Autres à préciser : N ant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome

☐ Luxation congénitale de la hanche

☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère

☐ Infection

☐ Conjonctivite

☐ Traumatisme

☐ Malformation

☐ Autres

Vu par : Sage-femme Hajar

Décision prise : poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : N ant

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 04/08/2026

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE — Benali Nadia

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°4/10

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement



Date de la consultation : 13/08/2026

Après le 50ème jour de l'accouchement



Etat général :

T° 36.7 TA 112/77 Pouls 83 Poids 77 kg

Etat des conjonctives : Normales Décolorées

Présence du globe utérin

Etat des lochies : Fade fétide
claires sanglantes Jaunâtres

Etat du périnée :

Normal
Épisiotomie Réparée
Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : Normal Anormal

Césarienne : Etat de la cicatrice : propre, sèche

Etat des seins : Normal lymphangite mastite et abcès

Etat des mollets : Normal Rouges Chauds Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication :

Hémorragie Complications mammaires
Infection Anémie
Eclampsie Autres
Phlébite

Notion de prise de médicaments :

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

Fer Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le

PLANIFICATION FAMILIALE

Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : pilule DIU Autre à préciser :

Prescription faite

Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°4/10

Date de la consultation : 13/08/2026

Age 46 jours Température 36.6 C Poids 4723 g

Taille 57 cm Périmètre crânien 40 cm

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

- | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|
| ☐ Convulsions | ☐ Refus de téter | ☐ Hématémèses | ☐ Mélaenas |
| ☐ Diarrhée | ☐ Ictère | ☐ Tirage sous costal | ☐ Toux |
| ☐ Rythme respiratoire anormal | ☐ Fièvre | ☐ Hypothermie | |

Autres à préciser : N ant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

- ☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Evaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

- ☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : Sage-femme Hajar

Décision prise : poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : N ant

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 12/10/2026

FICHE DE SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE ET DU POST-PARTUM

Modèle de formulaire neutre (spécimen)

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°5/10

N° de la fiche : 2026-978-005

Région : Souss-Massa

Province : Taroudant

Nom de l'établissement sanitaire : CSC Al Amal

Type de l'établissement sanitaire :

DR ☐

CSC ☒

CSU ☐

CSCA ☐

CSUA ☐

☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : Tazi Meryem

☒ Grossesse classée à risque :

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☒ Anémie

☐ H.T.A

☐ Diabète

☐ Cardiopathie

☐ Métrorragie

☐ Infection

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

Age : 38

Niveau d'instruction : Collège

Adresse : 13 Rue Mohammed V, Taroudant

Nom du Mari : Saïd Tazi

CIN : FH233367

Profession : Femme au foyer

Téléphone : 06 00 83 36 45

Profession : Ouvrier

☒ Consanguinité

☒ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA	RAS	RAS
Diabète	RAS	RAS
Maladies héréditaires	RAS	RAS
Malformations	Père	RAS
Allergie(s)	RAS	RAS

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques
RAS	Aucun	Cycles réguliers

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date	28/05/2023				
Modalité d'extraction	Voie basse				
Si césarienne : indication					
Complication (type)	RAS				
Poids nouveau-né(s)	3146 g				
Compl. nouveau-né (type)	RAS				

Gestation : 2Parité : 1Nombre d'enfants vivants : 1

VAT : ☒ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéoleLe 12/05/2022

☐ Vaccinée contre l'hépatite BLe

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : Non fait

DDR : 25/07/2025

Taille : 163 cm

Groupage : ☒ A ☐ B ☐ O ☐ AB ☒ Rh- ☐ Rh+

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : 01/05/2026

DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME : 08/05/2026

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous				13/12/2025	23/01/2026	07/03/2026	26/03/2026		—
Venue le				15/11/2025	26/12/2025	07/02/2026	26/02/2026		19/04/2026
Visites de relance				Non	Non	Oui	Non		Non
Age probable				16 SA	22 SA	28 SA	31 SA		38 SA
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)				54.7	57.7	59.6	60.0		62.7
TA				109/60	117/60	101/65	114/64		111/77
Anomalies squelette				RAS	RAS	RAS	RAS		RAS
État des conjonctives				Râles	Râles	Râles	Normales		Normales
Examen des seins				Normaux	Normaux	Normaux	Normaux		Normaux
Œdèmes				Non	Non	Non	Non		Non
Mouvements actifs				—	Oui	Oui	Oui		Oui
HU (cm)				12	18	24	27		34
BCF				143	155	143	151		132
Examen au spéculum				—	—	—	—		—
TV : état du col				—	—	Fermé	Fermé		Fermé
TV : présentation				—	—	—	—		Céphalique
TV : bassin				—	—	—	—		—
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie				Neg	Neg	Neg	Neg		Neg
Albuminurie				Neg	Neg	Neg	Neg		Neg
Rubéole				Immune					
Toxoplasmose				Non immune					
Syphilis (TPHA/VDRL)				Neg					
Ag HBs				Neg					
Sérologie VIH				Neg					
Hémoglobine				9.6 g/dL					
Plaquettes				305K					
Bilan glycémique				0.84 g/L					
RAI (si Rh négatif)				Neg					
TRAITEMENT									
Fer				Oui					
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par				Sage-femme	Dr Chakir	Dr Chakir	Dr Benjelloun		Inf. Zahra

DÉROULEMENT DE L'ACCOUCHEMENT

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°5/10

Patiente : Tazi Meryem

Lieu

☒ En milieu surveillé

☐ Maison d'accouchement

☒ Maternité

☐ Clinique privée

Autres :

☐ A domicile

☐ Assisté par un personnel qualifié

Autres :

Date de l'accouchement : 08/05/2026

Mode de l'accouchement :

☐ Voie basse non instrumentale

☐ Voie basse instrumentale

☐ Forceps

☐ Ventouse

☐ Avec épisiotomie

☒ Césarienne : Programmée

☐ Urgence

Préciser l'indication : utérus cicatriciel

Présence de complications

☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

☐ Hémorragie

☐ Infection

☐ Autres

Si autres à préciser :

Etat du nouveau-né :

☒ Vivant

☐ Mort-né

☐ Décès < 24 heures

Sexe : F

Poids à la naissance : 3765 g

Périmètre crânien à la naissance : 35 cm

Anomalie à préciser : Aucune

Âge gestationnel : 41 SA

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

MÈRE — Tazi Meryem

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°5/10

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement



Date de la consultation : 16/05/2026

Après le 8ème jour de l'accouchement



Etat général :

T° 37.0

TA 114/77

Pouls 81

Poids 59 kg

Etat des conjonctives :

☐ Normales

☒ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies :

☒ Fade

☐ fétide

☐ claires

☒ sanglantes

☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal

☐ Épisiotomie

☐ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) :

☒ Normal

☐ Anormal

☒ Césarienne :

Etat de la cicatrice :

Propre

Etat des seins :

☒ Normal

☐ lymphangite

☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal

☐ Rouges

☐ Chauds

☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication :



☐ Hémorragie

☐ Complications mammaires

☐ Infection

☒ Anémie

☐ Eclampsie

☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments :



Fer 2 cp/s

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer

☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le 20/06/2026

PLANIFICATION FAMILIALE

☐ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle :

☐ pilule

☐ DIU

Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Souhaite en discuter avec son mari

Date de la consultation : 16/05/2026

Age8 jours

Température37.2 °C

Poids3709 g

Taille49 cm

Périmètre crânien35 cm

☐ Nouveau-né prématuré☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement :

☒ exclusivement au sein

☐ Artificiel

☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions

☐ Refus de téter

☐ Hématémèses

☐ Mélaenas

☐ Diarrhée

☐ Ictère

☐ Tirage sous costal

☐ Toux

☐ Rythme respiratoire anormal

☐ Fièvre

☐ Hypothermie

Autres à préciser : Néant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome

☐ Luxation congénitale de la hanche

☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Evaluation de l'allaitement maternel :

☒ Normal

☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour :

☒ BCG

☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère

☐ Infection

☐ Conjonctivite

☐ Traumatisme

☐ Malformation

☐ Autres

Vu par : Inf. Zahra

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : Néant

☐ Transfert

Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 15/06/2026

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE — Tazi Meryem

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°5/10

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement ☒
Après le 50ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : 25/06/2026

Etat général :

T° 36.8 TA 115/63 Pouls 69 Poids 57 kg

Etat des conjonctives : ☐ Normales ☒ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide
☒ claires ☐ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal
☐ Épisiotomie ☒ Réparée
☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☒ Césarienne : Etat de la cicatrice : Propre, sèche

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets : ☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☒
☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires
☐ Infection ☒ Anémie
☐ Eclampsie ☐ Autres
☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☒ Fer 2 cp/j

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit : ☒ Fer ☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le

PLANIFICATION FAMILIALE

☐ Désire utiliser une méthode
Si oui, laquelle : ☐ pilule ☐ DIU Autre à préciser :
☐ Prescription faite
☐ Référée :
Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?
Souhaite en discuter avec son mari

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°5/10

Date de la consultation : 25/06/2026

Age48 jours

Température36.7 °C

Poids5150 g

Taille58 cm

Périmètre crânien39 cm

☐ Nouveau-né prématuré

☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement :

☒ exclusivement au sein

☐ Artificiel

☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions☐ Refus de téter☐ Hématémèses☐ Mélaenas

☐ Diarrhée☐ Ictère☐ Tirage sous costal☐ Toux

☐ Rythme respiratoire anormal☐ Fièvre☐ Hypothermie

Autres à préciser :

Néant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome☐ Luxation congénitale de la hanche☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser :

RAS

Evaluation de l'allaitement maternel :

☒ Normal

☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour :

☐ BCG

☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère☐ Infection☐ Conjonctivite

☐ Traumatisme☐ Malformation☐ Autres

Vu par :

Inf. Zahra

Décision prise :

Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit :

Néant

☐ Transfert

Preciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le

24/08/2026

FICHE DE SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE ET DU POST-PARTUM

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°6/10

Modèle de formulaire neutre (spécimen)

N° de la fiche : 2026-987-006

Région : Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

Province : Chefchaouen

Nom de l'établissement sanitaire : DR Bni Ahmed

Type de l'établissement sanitaire :

DR ☒

CSC ☐

CSU ☐

CSCA ☐

CSUA ☐

☐ Fixe

☒ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : Haddad Nadia

☐ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ Métrorragie

☐ H.T.A

☐ Infection

☐ Diabète

☐ Pré-éclampsie

☐ Cardiopathie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°6/10

Age : <u>36</u>	CIN : <u>JD514334</u>
Niveau d'instruction : <u>Supérieur</u>	Profession : <u>Agricultrice</u>
Adresse : <u>75 Rue Zerktouni, Chefchaouen</u>	Téléphone : <u>06 00 59 35 90</u>
Nom du Mari : <u>Karim Haddad</u>	Profession : <u>Ouvrier</u>
☐ Consanguinité	☒ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA	<i>RAS</i>	<i>RAS</i>
Diabète	<i>RAS</i>	<i>RAS</i>
Maladies héréditaires	<i>RAS</i>	<i>RAS</i>
Malformations	<i>RAS</i>	<i>RAS</i>
Allergie(s)	<i>RAS</i>	<i>RAS</i>

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques
<i>RAS</i>	<i>Aucun</i>	<i>Cycles réguliers</i>

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement	<i>1</i>	<i>2023</i>	<i>Maternité</i>	<i>16 SA</i>
Accouchement prématuré	<i>1</i>	<i>2023</i>	<i>Maternité</i>	<i>34 SA</i>
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

Accouchement	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Date	<i>26/05/2018</i>	<i>14/11/2021</i>	<i>01/02/2023</i>		
Modalité d'extraction	<i>Voie basse</i>	<i>Voie basse</i>	<i>Voie basse</i>		
Si césarienne : indication					
Complication (type)	<i>RAS</i>	<i>RAS</i>	<i>RAS</i>		
Poids nouveau-né(s)	<i>3337 g</i>	<i>3303 g</i>	<i>3677 g</i>		
Compl. nouveau-né (type)	<i>RAS</i>	<i>RAS</i>	<i>RAS</i>		

Gestation : 4 Parité : 3 Nombre d'enfants vivants : 3

VAT : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole

Le 12/05/2022

☒ Vaccinée contre l'hépatite B

Le 03/09/2021

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : Normal

DDR : 21/11/2025

Taille : 164 cm

Groupage : ☐ A ☐ B ☐ O ☒ AB ☐ Rh-

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : 28/08/2026

DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME : 04/09/2026

☒ Rh+

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous	25/02/2026	20/03/2026		20/04/2026	22/05/2026	01/07/2026	25/07/2026		
Venue le	28/01/2026	20/02/2026		23/03/2026	24/04/2026	03/06/2026	27/06/2026		
Visites de relance	Non	Oui		Non	Oui	Non	Non		
Age probable	10 SA	13 SA		17 SA	22 SA	28 SA	31 SA		
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)	73.7	74.2		76.7	77.8	80.1	81.1		
TA	109/61	120/63		117/61	113/75	111/72	117/64		
Anomalies squelette	RAS	RAS		RAS	RAS	RAS	RAS		
État des conjonctives	Normales	Normales		Normales	Normales	Normales	Normales		
Examen des seins	Normaux	Normaux		Normaux	Normaux	Normaux	Normaux		
Œdèmes	Non	Non		Non	Non	Non	Non		
Mouvements actifs	–	–		–	Oui	Oui	Oui		
HU (cm)	–	–		13	18	24	27		
BCF	–	–		149	144	139	142		
Examen au spéculum	RAS	–		–	–	–	–		
TV : état du col	–	–		–	–	Fermé	Fermé		
TV : présentation	–	–		–	–	–	–		
TV : bassin	Normal	–		–	–	–	–		
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie	Neg	Neg		Neg	Neg	Neg	Neg		
Albuminurie	Neg	Neg		Neg	Neg	Neg	Neg		
Rubéole	Immune								
Toxoplasmose	Immune								
Syphilis (TPHA/VDRL)	Neg								
Ag HBs	Neg								
Sérologie VIH	Neg								
Hémoglobine	11.7 g/dL			12.3 g/dL					
Plaquettes	292k								
Bilan glycémique	0.76 g/L								
RAI (si Rh négatif)	Neg								
TRAITEMENT									
Fer	Oui			Oui					
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par	Inf. Zahra	Dr Chakir		Inf. Zahra	Inf. Zahra	Dr Benjelloun	Sage-femme		

DÉROULEMENT DE L'ACCOUCHEMENT

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°6/10

Patiente : Haddad Nadia

Lieu

☒ En milieu surveillé

☐ Maison d'accouchement

☐ Maternité

☒ Clinique privée

Autres :

☐ A domicile

☐ Assisté par un personnel qualifié

Autres :

Date de l'accouchement : 26/07/2026

Mode de l'accouchement :

☒ Voie basse non instrumentale

☐ Voie basse instrumentale

☐ Forceps

☐ Ventouse

☐ Avec épisiotomie

☐ Césarienne : Programmée

☐ Urgence

Préciser l'indication :

Présence de complications

☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

☐ Hémorragie

☐ Infection

☐ Autres

Si autres à préciser :

Etat du nouveau-né :

☒ Vivant

☐ Mort-né

☐ Décès < 24 heures

Sexe : F

Poids à la naissance : 2350 g

Périmètre crânien à la naissance : 31 cm

Anomalie à préciser : Aucune

Âge gestationnel : 35 SA

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

MÈRE — Haddad Nadia

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°6/10

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement

☒

Date de la consultation : 03/08/2026

Après le 8ème jour de l'accouchement

☐

Etat général :

T° 37.3

TA 105/69

Pouls 73

Poids 80 kg

Etat des conjonctives : ☒ Normales

☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies :

☒ Fade

☐ fétide

☐ claires

☒ sanglantes

☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal

☐ Épisiotomie

☐ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) :

☒ Normal

☐ Anormal

☐ Césarienne :

Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal

☐ lymphangite

☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal

☐ Rouges

☐ Chauds

☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication :

☐

☐ Hémorragie

☐ Complications mammaires

☐ Infection

☐ Anémie

☐ Eclampsie

☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments :

☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer

☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le 07/09/2026

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle :

☐ pilule

☒ DIU

Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°6/10

Date de la consultation : 03/08/2026

Age 8 jours Température 36.8 °C Poids 2233 g

Taille 50 cm Périmètre crânien 31 cm

☒ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : Néant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Evaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : Dr Benjelloun

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : Vit. D 400 UI/j

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 02/09/2026

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement ☒

Après le 50ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : 12/09/2026

Etat général :

T° 36.8TA 117/63Pouls 79Poids 79 kg

Etat des conjonctives :

☒ Normales☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies :

☒ Fade☐ fétide

☒ claires☐ sanglantes☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal

☐ Épisiotomie☒ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) :

☒ Normal☐ Anormal

☐ Césarienne :Etat de la cicatrice :

Etat des seins :

☒ Normal☐ lymphangite☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal☐ Rouges☐ Chauds☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication :

☐ Hémorragie☐ Complications mammaires

☐ Infection☐ Anémie

☐ Eclampsie☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments :☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle :

☐ pilule☒ DIU

Autre à préciser :

☒ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°6/10

Date de la consultation : 12/09/2026

Age 48 jours Température 36.7 °C Poids 4122 g

Taille 56 cm Périmètre crânien 35 cm

☒ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

- ☐ Convulsions
- ☐ Refus de téter
- ☐ Hématémèses
- ☐ Mélaenas
- ☐ Diarrhée
- ☐ Ictère
- ☐ Tirage sous costal
- ☐ Toux
- ☐ Rythme respiratoire anormal
- ☐ Fièvre
- ☐ Hypothermie

Autres à préciser : Néant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

- ☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
- ☐ Luxation congénitale de la hanche
- ☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Evaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

- ☐ Ictère
- ☐ Infection
- ☐ Conjonctivite
- ☐ Traumatisme
- ☐ Malformation
- ☐ Autres

Vu par : Dr Benjelloun

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : Vit. D 400 UI/j

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 11/11/2026

FICHE DE SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE ET DU POST-PARTUM

Modèle de formulaire neutre (spécimen)

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°7/10

N° de la fiche : 2026-163-007

Région : Oriental

Province : Berkane

Nom de l'établissement sanitaire : CSU Ennahda

Type de l'établissement sanitaire :

DR ☐

CSC ☐

CSU ☒

CSCA ☐

CSUA ☐

☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : El Idrissi Salma

☐ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ Métrorragie

☐ H.T.A

☐ Infection

☐ Diabète

☐ Pré-éclampsie

☐ Cardiopathie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°7/10

Age : 26

CIN : JH89264

Niveau d'instruction : Collège

Profession : Commerçante

Adresse : 19 Rue Al Massira, Berkane

Téléphone : 06 00 14 60 20

Nom du Mari : Mohamed El Idrissi

Profession : Mécanicien

☐ Consanguinité

☒ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA	Mère	RAS
Diabète	Mère	RAS
Maladies héréditaires	RAS	RAS
Malformations	RAS	RAS
Allergie(s)	Mère	RAS

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques
RAS	Appendicectomie	Cycles réguliers

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date	19/10/2018	12/08/2021	25/06/2023		
Modalité d'extraction	Voie basse	Voie basse	Voie basse		
Si césarienne : indication					
Complication (type)	RAS	RAS	RAS		
Poids nouveau-né(s)	3296 g	3662 g	3651 g		
Compl. nouveau-né (type)	RAS	RAS	RAS		

Gestation : 5Parité : 3Nombre d'enfants vivants : 3

VAT : ☐ 1☒ 2☐ 3☐ 4☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéoleLe 12/05/2022

☐ Vaccinée contre l'hépatite BLe

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : Normal

GROSSESSE ACTUELLE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°7/10

DDR : 23/11/2025

Taille : 169 cm

Groupage : ☐ A ☐ B ☐ O ☒ AB ☐ Rh-

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : 30/08/2026

DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME : 06/09/2026

☒ Rh+

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous				15/04/2026					
Venue le				18/03/2026					
Visites de relance				Non					
Age probable				16 SA					
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)				63,4					
TA				100/61					
Anomalies squelette				RAS					
État des conjonctives				Normales					
Examen des seins				Normaux					
Œdèmes				Non					
Mouvements actifs				-					
HU (cm)				12					
BCF				157					
Examen au spéculum				-					
TV : état du col				-					
TV : présentation				-					
TV : bassin				-					
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie				Neg					
Albuminurie				Neg					
Rubéole				Immune					
Toxoplasmose				Non immune					
Syphilis (TPHA/VDRL)				Neg					
Ag HBs				Neg					
Sérologie VIH				Neg					
Hémoglobine				12.3 g/dL					
Plaquettes				314K					
Bilan glycémique				0.91 g/L					
RAI (si Rh négatif)				Neg					
TRAITEMENT									
Fer				Oui					
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par				Sage-femme					

DÉROULEMENT DE L'ACCOUCHEMENT

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°7/10

Patiente : El Idrissi Salma

Lieu

☐ En milieu surveillé

☐ Maison d'accouchement

☐ Maternité

☐ Clinique privée

Autres :

☒ A domicile

☒ Assisté par un personnel qualifié

Autres :

Date de l'accouchement : 28/08/2026

Mode de l'accouchement :

☒ Voie basse non instrumentale

☐ Voie basse instrumentale

☐ Forceps

☐ Ventouse

☐ Avec épisiotomie

☐ Césarienne : Programmée

☐ Urgence

Préciser l'indication :

Présence de complications

☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

☐ Hémorragie

☐ Infection

☐ Autres

Si autres à préciser :

Etat du nouveau-né :

☒ Vivant

☐ Mort-né

☐ Décès < 24 heures

Sexe : F

Poids à la naissance : 3430 g

Périmètre crânien à la naissance : 35 cm

Anomalie à préciser : Aucune

Âge gestationnel : 39 SA

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

MÈRE — El Idrissi Salma

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°7/10

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement
Après le 8ème jour de l'accouchement

☒
☐

Date de la consultation : 04/09/2026

Etat général :

T° 37.3 TA 108/79 Pouls 87 Poids 68 kg

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide
☐ claires ☒ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal
☐ Épisiotomie ☐ Réparée
☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets : ☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires
☐ Infection ☐ Anémie
☐ Eclampsie ☐ Autres
☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit : ☒ Fer ☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le 09/10/2026

PLANIFICATION FAMILIALE

☐ Désire utiliser une méthode
Si oui, laquelle : ☐ pilule ☐ DIU Autre à préciser :
☐ Prescription faite
☐ Référée :
Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?
Souhaite en discuter avec son mari

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°7/10

Date de la consultation : 04/09/2026

Age 7 jours Température 37.2 °C Poids 3382 g

Taille 48 cm Périmètre crânien 35 cm

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : Néant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Evaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : Sage-femme Salima

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : Néant

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 04/10/2026

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE — El Idrissi Salma

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°7/10

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement ☒
Après le 50ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : 14/10/2026

Etat général :

T° 36.8 TA 112/68 Pouls 71 Poids 65 kg

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide
☒ claires ☐ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal
☐ Épisiotomie ☒ Réparée
☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets : ☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires
☐ Infection ☐ Anémie
☐ Eclampsie ☐ Autres
☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit : ☒ Fer ☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le

PLANIFICATION FAMILIALE

☐ Désire utiliser une méthode
Si oui, laquelle : ☐ pilule ☐ DIU Autre à préciser :
☐ Prescription faite
☐ Référée :
Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?
Souhaite en discuter avec son mari

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°7/10

Date de la consultation : 14/10/2026

Age 47 jours

Température 37.2 °C

Poids 5443 g

Taille 54 cm

Périmètre crânien 38 cm

☐ Nouveau-né prématuré

☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☐ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☒ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions

☐ Refus de téter

☐ Hématémèses

☐ Mélaenas

☐ Diarrhée

☐ Ictère

☐ Tirage sous costal

☐ Toux

☐ Rythme respiratoire anormal

☐ Fièvre

☐ Hypothermie

Autres à préciser : Néant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome

☐ Luxation congénitale de la hanche

☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Evaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère

☐ Infection

☐ Conjonctivite

☐ Traumatisme

☐ Malformation

☐ Autres

Vu par : Sage-femme Salima

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : Néant

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 13/12/2026

FICHE DE SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE ET DU POST-PARTUM

Modèle de formulaire neutre (spécimen)

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°8/10

N° de la fiche : 2026-803-008

Région : casablanca-Settat

Province : Settat

Nom de l'établissement sanitaire : cSCA Lahraouiyine

Type de l'établissement sanitaire :

DR ☐

CSC ☐

CSU ☐

CSCA ☒

CSUA ☐

☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : Lahlou Khadija

☒ Grossesse classée à risque :

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☒ Anémie

☐ H.T.A

☐ Diabète

☐ Cardiopathie

☐ Métrorragie

☐ Infection

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

IDENTIFICATION ET ANTÉCÉDENTS

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°8/10

Age : 28

CIN : cc398413

Niveau d'instruction : Aucun

Profession : Agricultrice

Adresse : 40 Rue Ibn Sina, Settat

Téléphone : 06 00 99 66 70

Nom du Mari : omar Lahlou

Profession : Fonctionnaire

☒ Consanguinité

☒ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA	RAS	RAS
Diabète	RAS	RAS
Maladies héréditaires	oncle	RAS
Malformations	RAS	RAS
Allergie(s)	RAS	RAS

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques
RAS	Aucun	cycles r guliers

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date	03/08/2022				
Modalité d'extraction	c Sgarienne				
Si césarienne : indication	SFA				
Complication (type)	RAS				
Poids nouveau-né(s)	3175 g				
Compl. nouveau-né (type)	RAS				

Gestation : 2Parité : 1Nombre d'enfants vivants : 1

VAT : ☐ 1☒ 2☐ 3☐ 4☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéoleLe 12/05/2022

☒ Vaccinée contre l'hépatite BLe 03/09/2021

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : normal

GROSSESSE ACTUELLE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°8/10

DDR : 22/12/2025 Taille : 167 cm Groupage : ☒ A ☐ B ☐ O ☐ AB ☐ Rh-
DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : 28/09/2026 DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME : 05/10/2026 ☒ Rh+

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous	14/03/2026	12/04/2026		30/05/2026	22/06/2026	19/07/2026	25/08/2026		
Venue le	14/02/2026	15/03/2026		02/05/2026	25/05/2026	21/06/2026	28/07/2026		17/09/2026
Visites de relance	Non	Non		Oui	Non	Oui	Non		Non
Age probable	8 SA	12 SA		19 SA	22 SA	26 SA	31 SA		38 SA
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)	74.9	75.5		77.1	79.8	80.2	81.2		85.3
TA	120/61	120/60		101/78	101/72	100/76	106/63		108/72
Anomalies squelette	RAS	RAS		RAS	RAS	RAS	RAS		RAS
État des conjonctives	P les	P les		P les	P les	P les	Normales		Normales
Examen des seins	Normaux	Normaux		Normaux	Normaux	Normaux	Normaux		Normaux
Œdèmes	Non	Non		Non	Non	Non	Non		Non
Mouvements actifs					Oui	Oui	Oui		Oui
HU (cm)				15	18	22	27		34
BCF				140	157	153	138		145
Examen au spéculum	RAS								
TV : état du col							Ferm		Ferm
TV : présentation									c phalique
TV : bassin	Normal								
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie	Neg	Neg		Neg	Neg	Neg	Neg		Neg
Albuminurie	Neg	Neg		Neg	Neg	Neg	Neg		Neg
Rubéole	Immune								
Toxoplasmose	Immune								
Syphilis (TPHA/VDRL)	Neg								
Ag HBs	Neg								
Sérologie VIH	Neg								
Hémoglobine	10.1 g/dL			9.5 g/dL					
Plaquettes	247k								
Bilan glycémique	0.76 g/L								
RAI (si Rh négatif)	Neg								
TRAITEMENT									
Fer	Oui			Oui					
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par	Dr Chakir	Sage-femme		Inf. Zahra	Dr Chakir	Dr Benjelloun	Inf. Zahra		Inf. Zahra

DÉROULEMENT DE L'ACCOUCHEMENT

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°8/10

Patiente : Lahlou Khadija

Lieu

☒ En milieu surveillé

☐ Maison d'accouchement

☐ Maternité

☒ Clinique privée

Autres :

☐ A domicile

☐ Assisté par un personnel qualifié

Autres :

Date de l'accouchement : 25/09/2026

Mode de l'accouchement :

☒ Voie basse non instrumentale

☐ Voie basse instrumentale

☐ Forceps

☐ Ventouse

☐ Avec épisiotomie

☐ Césarienne : Programmée

☐ Urgence

Préciser l'indication :

Présence de complications

☐

☐ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

☐ Hémorragie

☐ Infection

☐ Autres

Si autres à préciser :

Etat du nouveau-né :

☒ Vivant

☐ Mort-né

☐ Décès < 24 heures

Sexe : M

Poids à la naissance : 3492 g

Périmètre crânien à la naissance : 35 cm

Anomalie à préciser : Aucune

Âge gestationnel : 39 SA

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

MÈRE — Lahlou Khadija

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°8/10

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement



Date de la consultation : 02/10/2026

Après le 8ème jour de l'accouchement



Etat général :

T° 37.0

TA 114/76

Pouls 80

Poids 81 kg

Etat des conjonctives : ☐ Normales

☒ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies :

☒ Fade

☐ fétide

☐ claires

☒ sanglantes

☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal

☐ Épisiotomie

☐ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) :

☒ Normal

☐ Anormal

☐ Césarienne :

Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal

☐ lymphangite

☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal

☐ Rouges

☐ Chauds

☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication :



☐ Hémorragie

☐ Complications mammaires

☐ Infection

☒ Anémie

☐ Eclampsie

☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments :



Fer 2 cp/j

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer

☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le 06/11/2026

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule

☐ DIU

Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : 02/10/2026

Age7 jours

Température37.1 °C

Poids3343 g

Taille48 cm

Périmètre crânien35 cm

☐ Nouveau-né prématuré☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein☐ Artificiel☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions☐ Refus de téter☐ Hématémèses☐ Mélaenas

☐ Diarrhée☐ Ictère☐ Tirage sous costal☐ Toux

☐ Rythme respiratoire anormal☐ Fièvre☐ Hypothermie

Autres à préciser : N ant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome

☐ Luxation congénitale de la hanche

☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Evaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère☐ Infection☐ Conjonctivite

☐ Traumatisme☐ Malformation

☐ Autres

Vu par : Sage-femme Hajar

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : N ant

☐ Transfert

Preciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif2. Maintien au chaud3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 01/11/2026

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE — Lahlou Khadija

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°8/10

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement



Date de la consultation : 08/11/2026

Après le 50ème jour de l'accouchement



Etat général :

T° 36.7 TA 120/68 Pouls 66 Poids 81 kg

Etat des conjonctives : ☐ Normales ☒ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide
☒ claires ☐ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal
☐ Épisiotomie ☒ Réparée
☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☐ Césarienne : Etat de la cicatrice :

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets : ☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication :

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires
☐ Infection ☒ Anémie
☐ Eclampsie ☐ Autres
☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☒ Fer 2 cp/j

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer ☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :

☒ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°8/10

Date de la consultation : 08/11/2026

Age44 jours

Température37.2 °C

Poids5062 g

Taille58 cm

Périmètre crânien39 cm

☐ Nouveau-né prématuré

☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement :

☒ exclusivement au sein

☐ Artificiel

☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions☐ Refus de téter☐ Hématémèses☐ Mélaenas

☐ Diarrhée☐ Ictère☐ Tirage sous costal☐ Toux

☐ Rythme respiratoire anormal☐ Fièvre☐ Hypothermie

Autres à préciser :

N ant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome☐ Luxation congénitale de la hanche☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser :

RAS

Evaluation de l'allaitement maternel :

☒ Normal

☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour :

☐ BCG☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère☐ Infection☐ Conjonctivite

☐ Traumatisme☐ Malformation☐ Autres

Vu par :

Sage-femme Hajar

Décision prise :

Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit :

N ant

☐ Transfert

Preciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le

07/01/2027

Document synthétique généré pour l'entraînement de modèles — aucune donnée réelle — ne pas utiliser comme dossier médical.

FICHE DE SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE ET DU POST-PARTUM

Modèle de formulaire neutre (spécimen)

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°9/10

N° de la fiche : 2026-842-009

Région : Dr a-Tafilalet

Province : Errachidia

Nom de l'établissement sanitaire : CSC Ksar Jdid

Type de l'établissement sanitaire :

DR ☐

CSC ☒

CSU ☐

CSCA ☐

CSUA ☐

☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : Alaoui Loubna

☒ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ Métrorragie

☐ H.T.A

☐ Infection

☐ Diabète

☒ Pré-éclampsie

☐ Cardiopathie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

Age : 21

CIN : DC983337

Niveau d'instruction : Collège

Profession : Employée

Adresse : 69 Rue Zerktouni, Errachidia

Téléphone : 06 00 84 43 16

Nom du Mari : Karim Alaoui

Profession : Fonctionnaire

☐ Consanguinité

☒ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA	RAS	RAS
Diabète	RAS	RAS
Maladies héréditaires	RAS	RAS
Malformations	RAS	RAS
Allergie(s)	RAS	RAS

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques
RAS	Aucun	Cycles réguliers

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date					
Modalité d'extraction					
Si césarienne : indication					
Complication (type)					
Poids nouveau-né(s)					
Compl. nouveau-né (type)					

Gestation : 1

Parité : 0

Nombre d'enfants vivants : 0

VAT : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole

Le 12/05/2022

☒ Vaccinée contre l'hépatite B

Le 03/09/2021

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : Non fait

DDR : 14/04/2025

Taille : 155 cm

Groupage : ☐ A ☐ B ☐ O ☒ AB ☐ Rh-

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : 19/01/2026

DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME : 26/01/2026

☒ Rh+

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous					20/10/2025	08/11/2025	16/12/2025	13/01/2026	
Venue le					22/09/2025	11/10/2025	18/11/2025	16/12/2025	06/01/2026
Visites de relance					Non	Non	Oui	Non	Non
Age probable					23 SA	26 SA	31 SA	35 SA	38 SA
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)					74.8	75.0	77.4	78.0	80.3
TA					138/89	149/95	153/93	157/102	164/98
Anomalies squelette					RAS	RAS	RAS	RAS	RAS
État des conjonctives					Normales	Normales	Normales	Normales	Normales
Examen des seins					Normaux	Normaux	Normaux	Normaux	Normaux
Œdèmes					Non	Non	Oui	Oui	Oui
Mouvements actifs					Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
HU (cm)					19	22	27	31	34
BCF					139	156	157	135	151
Examen au spéculum									
TV : état du col							Ferm	Ferm	Ferm
TV : présentation								C phalique	C phalique
TV : bassin									
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie					Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
Albuminurie					Neg	Neg	Neg	Pos +	Pos +
Rubéole					Immune				
Toxoplasmose					Immune				
Syphilis (TPHA/VDRL)					Neg				
Ag HBs					Neg				
Sérologie VIH					Neg				
Hémoglobine					10.9 g/dL				
Plaquettes					302k				
Bilan glycémique					0.8 g/L				
RAI (si Rh négatif)					Neg				
TRAITEMENT									
Fer					Oui				
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par					Dr Benjelloun	Dr Benjelloun	Inf. Zahra	Dr Chakir	Sage-femme

DÉROULEMENT DE L'ACCOUCHEMENT

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°9/10

Patiente : Alaoui Loubna

Lieu

☒ En milieu surveillé

☐ Maison d'accouchement

☐ Maternité

☒ Clinique privée

Autres :

☐ A domicile

☐ Assisté par un personnel qualifié

Autres :

Date de l'accouchement : 30/01/2026

Mode de l'accouchement :

☐ Voie basse non instrumentale

☐ Voie basse instrumentale

☐ Forceps

☐ Ventouse

☐ Avec épisiotomie

☐ Césarienne : Programmée

☒ Urgence

Préciser l'indication : Pr - clampsie s v re

Présence de complications

☒ ☒ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :

☒ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

☐ Hémorragie

☐ Infection

☐ Autres

Si autres à préciser :

Etat du nouveau-né :

☒ Vivant

☐ Mort-né

☐ Décès < 24 heures

Sexe : M

Poids à la naissance : 3585 g

Périmètre crânien à la naissance : 33 cm

Anomalie à préciser : Aucune

Âge gestationnel : 41 SA

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

MÈRE — Alaoui Loubna

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°9/10

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement ☒
Après le 8ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : 06/02/2026

Etat général :

T° 36.9 TA 120/73 Pouls 75 Poids 78 kg

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide
☐ claires ☒ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☒ Normal
☐ Épisiotomie ☐ Réparée
☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☒ Césarienne : Etat de la cicatrice : Propre

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets : ☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☒

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires
☐ Infection ☐ Anémie
☐ Eclampsie ☐ Autres
☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit : ☒ Fer ☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le 13/03/2026

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☐ pilule ☒ DIU Autre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

CONSULTATION DU POST-PARTUM PRÉCOCE

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°9/10

Date de la consultation : 06/02/2026

Age 7 jours

Température 37.1 C

Poids 3511 g

Taille 48 cm

Périmètre crânien 33 cm

☐ Nouveau-né prématuré

☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions

☐ Refus de téter

☐ Hématémèses

☐ Mélaenas

☐ Diarrhée

☐ Ictère

☐ Tirage sous costal

☐ Toux

☐ Rythme respiratoire anormal

☐ Fièvre

☐ Hypothermie

Autres à préciser : N ant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome

☐ Luxation congénitale de la hanche

☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Évaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☒ BCG ☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère

☐ Infection

☐ Conjonctivite

☐ Traumatisme

☐ Malformation

☐ Autres

Vu par : Inf. Zahra

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : N ant

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 08/03/2026

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE — Alaoui Loubna

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°9/10

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement



Date de la consultation : 17/03/2026

Après le 50ème jour de l'accouchement



Etat général :

T° 36.6

TA 110/68

Pouls 79

Poids 73 kg

Etat des conjonctives : ☒ Normales

☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies :

☒ Fade

☐ fétide

☒ claires

☐ sanglantes

☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal

☐ Épisiotomie

☒ Réparée

☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) :

☒ Normal

☐ Anormal

☒ Césarienne :

Etat de la cicatrice :

propre, s che

Etat des seins : ☒ Normal

☐ lymphangite

☐ mastite et abcès

Etat des mollets :

☒ Normal

☐ Rouges

☐ Chauds

☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication :



☐ Hémorragie

☐ Complications mammaires

☐ Infection

☐ Anémie

☐ Eclampsie

☐ Autres

☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments :



CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit :

☒ Fer

☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle :

☐ pilule

☒ DIU

Autre à préciser :

☒ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°9/10

Date de la consultation : 17/03/2026

Age 46 jours Température 36.8 C Poids 5566 g

Taille 54 cm Périmètre crânien 36 cm

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

- | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|
| ☐ Convulsions | ☐ Refus de téter | ☐ Hématémèses | ☐ Mélaenas |
| ☐ Diarrhée | ☐ Ictère | ☐ Tirage sous costal | ☐ Toux |
| ☐ Rythme respiratoire anormal | ☐ Fièvre | ☐ Hypothermie | |

Autres à préciser : N ant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

- ☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
- ☐ Luxation congénitale de la hanche
- ☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Evaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ☐ Ictère | ☐ Infection | ☐ Conjonctivite |
| ☐ Traumatisme | ☐ Malformation | |
| ☐ Autres | | |

Vu par : Inf. Zahra

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : N ant

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 16/05/2026

FICHE DE SURVEILLANCE DE LA GROSSESSE ET DU POST-PARTUM

Modèle de formulaire neutre (spécimen)

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°10/10

N° de la fiche : 2026-590-010

Région : Rabat-Salé-Kénitra

Province : Khémisset

Nom de l'établissement sanitaire : CSUA Hay Riad

Type de l'établissement sanitaire :

DR ☐

CSC ☐

CSU ☐

CSCA ☐

CSUA ☒

☒ Fixe

☐ Mobile

Nom/Prénom de la parturiente : Bennani Zineb

☐ **Grossesse classée à risque :**

Si grossesse à risque, préciser le type de risque :

☐ Anémie

☐ Métrorragie

☐ H.T.A

☐ Infection

☐ Diabète

☐ Pré-éclampsie

☐ Cardiopathie

☐ Eclampsie

Autres à préciser :

Age : 34

CIN : BH670901

Niveau d'instruction : Supérieur

Profession : Femme au foyer

Adresse : 69 Rue Al Qods, Khémisset

Téléphone : 06 00 73 94 48

Nom du Mari : Mohamed Bennani

Profession : Maçon

☐ Consanguinité

☒ Grossesse désirée

ANTÉCÉDENTS HÉRÉDITAIRES ET FAMILIAUX

	Famille de la femme	Mari/famille
HTA	RAS	RAS
Diabète	RAS	RAS
Maladies héréditaires	RAS	RAS
Malformations	RAS	RAS
Allergie(s)	RAS	RAS

ANTÉCÉDENTS DE LA FEMME

Médicaux	Chirurgicaux	Gynécologiques
RAS	Aucun	Cycles réguliers

ANTÉCÉDENTS OBSTÉTRICAUX — Anomalies des grossesses antérieures

Nature	Nombre	Date	Lieu	Age gestationnel (SA)
Avortement				
Accouchement prématuré				
Mort fœtale in utéro				
Autres à préciser :				

DÉROULEMENT DES ACCOUCHEMENTS ANTÉRIEURS

	Accouch. 1	Accouch. 2	Accouch. 3	Accouch. 4	Accouch. 5
Accouchement					
Date					
Modalité d'extraction					
Si césarienne : indication					
Complication (type)					
Poids nouveau-né(s)					
Compl. nouveau-né (type)					

Gestation : 1

Parité : 0

Nombre d'enfants vivants : 0

VAT : ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5

☒ Vaccinée contre la rubéole

Le 12/05/2022

☒ Vaccinée contre l'hépatite B

Le 03/09/2021

Frottis cervical / IVA (moins de 3 ans) : Normal

GROSSESSE ACTUELLE

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES

Patiente fictive n°10/10

DDR : 03/10/2025

Taille : 160 cm

Groupage : ☐ A ☐ B ☐ O ☒ AB ☐ Rh-

DATE PRÉVUE D'ACCOUCHEMENT : 10/07/2026

DATE DE DÉPASSEMENT DE TERME : 17/07/2026

☒ Rh+

	1er trimestre			2ème trimestre			3ème trimestre		
Prestations / Visites	Visite 1	Visite 2	Visite 3	Visite 1	Visite 2	Visite 3	7ème mois	8ème mois	9ème mois
Rendez-vous	28/12/2025	23/01/2026		26/02/2026	18/04/2026	04/05/2026		02/07/2026	
Venue le	30/11/2025	26/12/2025		29/01/2026	21/03/2026	06/04/2026		04/06/2026	
Visites de relance	Non	Non		Non	Non	Non		Non	
Age probable	8 SA	12 SA		17 SA	24 SA	26 SA		35 SA	
EXAMEN CLINIQUE									
Poids (kg)	72.9	74.8		76.1	77.7	79.7		81.8	
TA	103/78	120/64		113/60	111/70	104/64		114/73	
Anomalies squelette	RAS	RAS		RAS	RAS	RAS		RAS	
État des conjonctives	Normales	Normales		Normales	Normales	Normales		Normales	
Examen des seins	Normaux	Normaux		Normaux	Normaux	Normaux		Normaux	
Œdèmes	Non	Non		Non	Non	Non		Non	
Mouvements actifs	—	—		—	Oui	Oui		Oui	
HU (cm)	—	—		13	20	22		31	
BCF	—	—		137	145	138		145	
Examen au spéculum	RAS	—		—	—	—		—	
TV : état du col	—	—		—	—	—		Fermé	
TV : présentation	—	—		—	—	—		Céphalique	
TV : bassin	Normal	—		—	—	—		—	
EXAMEN BIOLOGIQUE									
Glucosurie	Neg	Neg		Neg	Neg	Neg		Neg	
Albuminurie	Neg	Neg		Neg	Neg	Neg		Neg	
Rubéole	Immune								
Toxoplasmose	Non immune								
Syphilis (TPHA/VDRL)	Neg								
Ag HBs	Neg								
Sérologie VIH	Neg								
Hémoglobine	11.8 g/dL			11.7 g/dL					
Plaquettes	281K								
Bilan glycémique	0.93 g/L								
RAI (si Rh négatif)	Neg								
TRAITEMENT									
Fer	Oui			Oui					
EXAMEN FAIT PAR									
Examen fait par	Dr Benjelloun	Dr Chakir		Inf. Zahra	Inf. Zahra	Sage-femme		Inf. Zahra	

DÉROULEMENT DE L'ACCOUCHEMENT

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°10/10

Patiente : Bennani Zineb

Lieu

☒ En milieu surveillé

☐ Maison d'accouchement

☒ Maternité

☐ Clinique privée

Autres :

☐ A domicile

☐ Assisté par un personnel qualifié

Autres :

Date de l'accouchement : 07/07/2026

Mode de l'accouchement :

☐ Voie basse non instrumentale

☐ Voie basse instrumentale

☐ Forceps

☐ Ventouse

☐ Avec épisiotomie

☐ Césarienne : Programmée

☒ Urgence

Préciser l'indication : Souffrance fœtale

Présence de complications

☒

☒ Au moment de l'accouchement

☐ Suites de couches

Type de complications :

☐ Pré-éclampsie

☐ Eclampsie

☐ Hémorragie

☒ Infection

☐ Autres

Si autres à préciser :

Etat du nouveau-né :

☒ Vivant

☐ Mort-né

☐ Décès < 24 heures

Sexe : F

Poids à la naissance : 3119 g

Périmètre crânien à la naissance : 35 cm

Anomalie à préciser : Aucune

Âge gestationnel : 39 SA

Entre le 7ème et 8ème jour après l'accouchement ☒

Après le 8ème jour de l'accouchement ☐

Date de la consultation : 15/07/2026

Etat général :

T° 37.1TA 104/66Pouls 73Poids 81 Kg

Etat des conjonctives : ☒ Normales☐ Décolorées

☒ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade☐ fétide☐ claires☒ sanglantes☐ Jaunâtres

Etat du périnée : ☒ Normal☐ Épisiotomie☐ Réparée☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal☐ Anormal

☒ Césarienne :Etat de la cicatrice : Propre

Etat des seins : ☒ Normal☐ lymphangite☐ mastite et abcès

Etat des mollets : ☒ Normal☐ Rouges☐ Chauds☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☒

☐ Hémorragie☐ Complications mammaires☒ Infection☐ Anémie☐ Eclampsie☐ Autres☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit : ☒ Fer☒ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le 19/08/2026

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode

Si oui, laquelle : ☒ pilule☐ DIUAutre à préciser :

☐ Prescription faite

☐ Référée :

Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

Date de la consultation : 15/07/2026

Age8 jours

Température36.8 °C

Poids3016 g

Taille49 cm

Périmètre crânien35 cm

☐ Nouveau-né prématuré

☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement :

☒ exclusivement au sein

☐ Artificiel

☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions☐ Refus de téter☐ Hématémèses☐ Mélaenas

☐ Diarrhée☐ Ictère☐ Tirage sous costal☐ Toux

☐ Rythme respiratoire anormal☐ Fièvre☐ Hypothermie

Autres à préciser : Néant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome

☐ Luxation congénitale de la hanche

☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Evaluation de l'allaitement maternel :

☒ Normal

☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour :

☒ BCG

☒ HB

☒ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère☐ Infection☐ Conjonctivite

☐ Traumatisme☐ Malformation

☐ Autres

Vu par : Dr Benjelloun

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : Néant

☐ Transfert

Preciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 14/08/2026

Document synthétique généré pour l'entraînement de modèles — aucune donnée réelle — ne pas utiliser comme dossier médical.

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

MÈRE — Bennani Zineb

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°10/10

Entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement ☒ Date de la consultation : 20/08/2026
Après le 50ème jour de l'accouchement ☐

Etat général :

T° 37.0 TA 108/72 Pouls 74 Poids 77 kg

Etat des conjonctives : ☒ Normales ☐ Décolorées

☐ Présence du globe utérin

Etat des lochies : ☒ Fade ☐ fétide
☒ claires ☐ sanglantes ☐ Jaunâtres

Etat du périnée :

☐ Normal
☐ Épisiotomie ☒ Réparée
☐ Déchirure

Etat des sphincters (anal et urétral) : ☒ Normal ☐ Anormal

☒ Césarienne : Etat de la cicatrice : Propre, sèche

Etat des seins : ☒ Normal ☐ lymphangite ☐ mastite et abcès

Etat des mollets : ☒ Normal ☐ Rouges ☐ Chauds ☐ Douloureux à la dorsiflexion

Présence de complication : ☐

☐ Hémorragie ☐ Complications mammaires
☐ Infection ☐ Anémie
☐ Eclampsie ☐ Autres
☐ Phlébite

Notion de prise de médicaments : ☐

CONDUITE À TENIR :

Traitement prescrit : ☒ Fer ☐ Vitamine A

Autres à préciser :

Prochain rendez-vous le

PLANIFICATION FAMILIALE

☒ Désire utiliser une méthode
Si oui, laquelle : ☒ pilule ☐ DIU Autre à préciser :
☒ Prescription faite
☐ Référée :
Si la mère ne désire pas une méthode contraceptive : Pourquoi ?

CONSULTATION DU POST-PARTUM TARDIF

NOUVEAU-NÉ

SPÉCIMEN — DONNÉES FICTIVES
Patiente fictive n°10/10

Date de la consultation : 20/08/2026

Age 44 jours Température 36.9 °C Poids 4480 g

Taille 54 cm Périmètre crânien 39 cm

☐ Nouveau-né prématuré ☐ Nouveau-né hypotrophe

Allaitement : ☒ exclusivement au sein ☐ Artificiel ☐ mixte

Signes d'une affection grave :

☐ Convulsions ☐ Refus de téter ☐ Hématémèses ☐ Mélaenas
☐ Diarrhée ☐ Ictère ☐ Tirage sous costal ☐ Toux
☐ Rythme respiratoire anormal ☐ Fièvre ☐ Hypothermie

Autres à préciser : Néant

Contusions, lésions traumatiques et malformations :

☐ Bosse sérosanguine ou céphalohématome
☐ Luxation congénitale de la hanche
☐ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre

Autres à préciser : RAS

Evaluation de l'allaitement maternel : ☒ Normal ☐ A problèmes

Etat vaccinal

Vaccins administrés ce jour : ☐ BCG ☐ HB

☐ Supplémentation en vitamine D

Présence de complications et de malformation :

☐ Ictère ☐ Infection ☐ Conjonctivite
☐ Traumatisme ☐ Malformation
☐ Autres

Vu par : Dr Benjelloun

Décision prise : Poursuivre l'allaitement exclusif

Traitement prescrit : Néant

☐ Transfert Préciser l'établissement de référence :

Les trois règles de la prise en charge du nouveau-né à domicile :

1. Allaitement maternel exclusif 2. Maintien au chaud 3. Quand revenir immédiatement ?

Revenir pour une visite de suivi nécessaire le 19/10/2026